

SOAL 1



RESUME RAWAT INAP

Nama Pasien	: Tn. OS	Tgl. Masuk	: 25-06-2024
No. RM	: R00221888	Tgl. Keluar	: 10-07-2024
Tgl. Lahir	: xxx	Lama Dirawat	: 16 hari
No JKN	: *****44**51	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
No SEP	: *****1025V00**	Alergi Obat	: Tidak Ada

Keluhan Utama	kedua tungkai bengkak disertai kemerahan demam+
Perkembangan Selama Perawatan	os mengeluh kedua tungkai bengkak sejak 2 minggu smrs. bengkak disertai sesak nafas os mengaku cepat lelah bila beraktivitas. kaki kanan terasa nyeri dan memerah sejak 1 minggu. ada seperti bisul di kaki kanan, sesak nafas, badan sakit semua, berdebar + nyeri dada+ luka kaki+ merah + pus+ os sulit makan peroral on NGT enteral, mual, edema pada keempat ekstremitas, ROM penuh secara pasif untuk kedua tungkai dan aktif asistif untuk ekstremitas atas, os sempat mengalami perburukan TD 70/60 on dobutamin, paska syok os desaturasi diberikan pasang nasal kanul, rencana pasang ventilator namun kondisi perburukan, temuan EKG : VT (+) dilakukan kardioversi, keluarga menolak untuk dilakukan intubasi dan RJP, pasien dinyatakan meninggal dihadapan nakes dan keluarga pasien.
Pemeriksaan Fisik	- Eye : 4 motorik : 6 verbal : 5 , gcs : 15, Spo2 : 95% on o2 nasal 8lpm, BB/TB : 55/170 , RR : 40 N : 86 , TD : 199/99 (25-06-2025) , TD : 70/60 on dobutamin Suhu : 37,6, thorax: VBS +/-, Wh -/-, Rh -/-, , Tungkai : pitting oedem +/-
Pemeriksaan Penunjang	EKG + , thorax foto +, cek lab +, hematologi lengkap +, glukosa puasa/sewaktu +, ureum +, kreatinin +, hs troponin , natrium kalium chlorida+. Temuan hasil laboratorium : D-Dimer H 3200 ng/ml , leukosit : 24.000, Hb: 10.2 → Hb : 8.2 → Hb : 7.4, → Hb : 5.4 trombosit : 41.000 , creatinin : 5,6 , PLT 79,00 SK 4.8 . eGFR : 5 Temuan Thorax : cardiomegaly dengan bendungan paru disertai athrosklerosis aorta. pelebaran hili ec vaskular, cor membesar ke lateral kiri dengan apeks tertanam pada diafragma, pinggang jantung menonjol , kalsifikasi aorta+ , hili tampak melebar, corakan bronkovaskuler bertambah, kranialisasi+ Temuan EKG : Ventrikular Tachycardia (+) ☐ QRS lebar (gelombang besar dan melebar, ≥ 120 ms) ☐ Irama regular ☐ Frekuensi cepat (sekitar 150–200 bpm) ☐ Gelombang P tidak terlihat jelas / Dissosiasi AV USG doppler ekstremitas bawah(+) : Segmen vena femoralis komunis, superfisialis, dan poplitea tampak diperiksa dalam potongan longitudinal

	dan transversal. Tampak trombus intraluminal berupa bayangan hiperekoik/homogen yang menyebabkan vena tidak dapat terkompresi. Aliran darah pada Doppler warna menurun atau tidak tampak pada segmen tersebut. Segmen vena lainnya tampak aliran normal dan dapat dikompresi. Jaringan sekitar tampak dalam batas normal, tidak tampak edema signifikan. Kesan / Kesimpulan: <u>Gambaran sesuai dengan Trombosis pada vena femoralis kanan</u> Echocardiography (+) : Fraksi ejeksi ventrikel kiri (EF 39 %) → menunjukkan disfungsi sistolik berat Ditemukan disfungsi diastolik grade II Terdapat regurgitasi mitral sekunder, dilatasi atrium kiri, peningkatan tekanan pulmonal
Diagnosis Utama	Hipertensi dengan Acute Decompensated Heart Failure
Diagnosis Sekunder	- Syok Kardiogenik - Selulitis pedis dextra dd ALI + - Venous Thromboembolism (VTE) femoralis pedis dextra - Gagal Ginjal Stadium V - Ventrikular Tachycardia (VT) - Edema Anasarka - Trombositopenia
Tindakan Utama	-
Tindakan Lainnya	- Echocardiography - Cardioversi 100J - USG Doppler ekstremitas bawah kanan - Tranfusi TC 4 bag - pemasangan NGT - EKG - foto thorax - Lab darah - Oksigen nasal kanul
Obat yang diberikan selama perawatan	furosemide, ntg 10 mikro, spiro 1x25mg, ator 1x40mg, bicnat 3x1, candesartan 1x16mg, methylprednisolone 125 m, chaNNA 2x1, dobutamin start 5 mikro 5, inj lasix, aminefron 3x1 asam folat 1x1, gv pdgn metronidazole, ondancemtron, cefoperazone, inj keterolac 2x1, furosemide, omeprazole, samsca tab, pantoprazole, ca glukonas, folic acid, rosufer 10 mg, atorvastatin, alopurinol 100 mg, renxamin 200ml, dexametasone, amiodaron, meropenem, alopurinol 100 mg, norephineprine bitartrate 4mg, topazol, aminefron
Kondisi Saat Keluar Rumah Sakit	Meninggal
Instruksi / Tindak Lanjut	-
Cara Keluar Rumah Sakit	Meninggal > 48 jam
Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)	<u>(TTE)</u> dr. x, Sp. JP